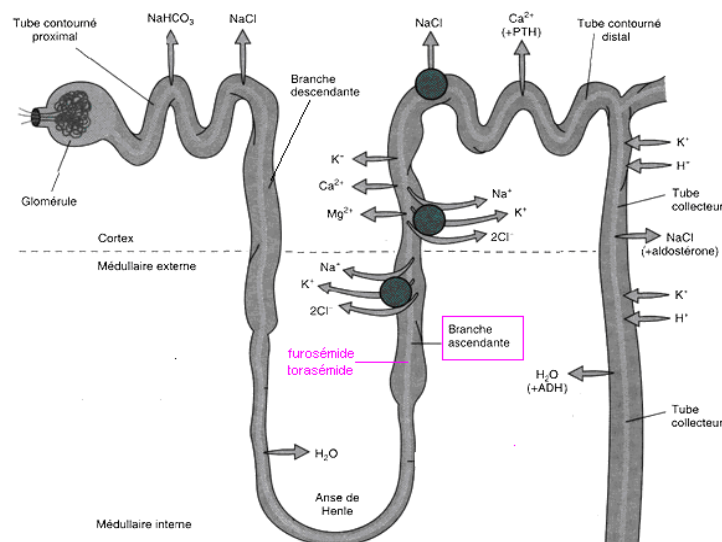


DIURÉTIQUES DE L'ANSE

Furosémide / torasémide

Mode d'action du médicament

Ces diurétiques inhibent la réabsorption du sodium au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henlé. L'inhibition du transport actif du NaCl provoque une augmentation associée de l'excrétion de Mg^{2+} et de Ca^{2+} .



Adapté de <http://www.chups.jussieu.fr/polys/pharmaco/poly/POLY.Chp.9.2.html>

Indications principales

- Insuffisance cardiaque, traitement de l'œdème aigu du poumon.
- Insuffisance cardiaque associée à des œdèmes, surtout en cas d'insuffisance rénale.
- Traitement symptomatique de l'insuffisance cardiaque systolique NYHA II-IV, pour améliorer la dyspnée et la tolérance à l'effort.
- Insuffisance rénale chronique.
- Hypertension essentielle légère à modérée
- Administration à titre complémentaire lors du traitement d'œdèmes d'origine hépatique (ascites) par la spironolactone.

Caractéristiques pharmacocinétiques

Furosémide : demi-vie : ~ 1h, excrétion rénale.

Torasémide : demi-vie : ~ 3h, il est métabolisé par les CYP2C9 en plusieurs métabolites dont certains sont actifs. Le torasémide et ses métabolites sont éliminés par les reins.

Effets indésirables

Type A

- Hypovolémie, insuffisance rénale fonctionnelle directement en rapport avec un effet diurétique trop important.
- Hyponatrémie.
- Hypokaliémie : l'inhibition de la réabsorption de sodium au niveau de l'anse de Henle augmente de façon considérable la quantité de Na arrivant dans le tube contourné distal et stimule sa réabsorption à ce niveau en échange d'une excrétion de potassium et d'ions H⁺. Ces diurétiques exposent ainsi à l'alcalose métabolique hypokaliémique.
- Hyperuricémie.
- Hypomagnésémie.
- Ototoxicité, proportionnelle à la dose administrée et habituellement (mais pas toujours) réversible.

Interactions médicamenteuses

Interactions pharmacocinétiques:

- Diurétiques de l'anse et lithium : toxicité du lithium augmentée

Interactions pharmacodynamiques:

- Diurétiques de l'anse et autres diurétiques ou autres anti-hypertenseurs, en particulier les IEC : potentialisation de l'effet avec risque d'hypotension parfois marquée.
- Diurétiques de l'anse et AINS : cette association augmente le risque d'insuffisance rénale en cas d'hypovolémie ou de déshydratation.
NB: le cocktail AINS, diurétiques et IEC est détonnant: il est à l'origine de nombreux cas d'insuffisance rénale aiguë !
- Diurétiques de l'anse, aminosides et dérivés du platine: risque augmenté d'ototoxicité et de néphrotoxicité.

Contre-indications

Contre-indications formelles :

- Hypokaliémie sévère, hyponatrémie sévère et/ou hypovolémie ou déshydratation avec ou sans hypotension artérielle concomitante.

Contre-indications relatives (le traitement doit être discuté avec un spécialiste) :

- Hypotension artérielle
- Tension artérielle systolique basse asymptomatique
- Encéphalopathie hépatique.
- Aggravation ou apparition d'une insuffisance rénale chez un patient avec une insuffisance cardiaque décompensée: l'IR peut être due
 - à une hypovolémie relative qui pourrait être aggravée par les diurétiques, ou

- à une hémodynamique défavorable (petit débit en raison d'une précharge élevée) qui pourrait être améliorée par les diurétiques.

Remarques pour la pratique

Doivent toujours être associés aux IEC et aux bêta-bloquants s'ils sont tolérés.

Le meilleur contrôle de la volémie (et le plus simple!) est la pesée (mesure du poids) par le patient 1 fois par jour. Toute prise rapide de poids (p. ex. 2 kg en 2 jours) est le signe d'une rétention hydro-saline et donc d'une décompensation cardiaque débutante.

Les patients peuvent être instruits (éducation thérapeutique) à adapter eux-mêmes leur dose de diurétiques en fonction de leur poids et... de leur alimentation !

Anamnèse	Clinique	Examens complémentaires
Amélioration des symptômes d'IC	Poids	Electrolytes
Evolution du poids	Diurèse	Na
Fatigue, faiblesse	Bilan hydrique	K
Vertiges	TA	Créatinine
Alimentation, prise hydrique		Urée

Pour en savoir plus

Les diurétiques : <http://www.chups.jussieu.fr/polys/pharmaco/poly/POLY.Chp.9.2.html>

Richard C. et al. Utilisation des diurétiques : ce que le praticien doit connaître. Rev Med Suisse 2015 ; 11 :482

Accès libre : <https://www.revmed.ch/RMS/2015/RMS-N-463/Utilisation-des-diuretiques-ce-que-le-praticien-doit-connaître>